
Est-il encore possible d'avoir une politique rationnelle ?

Ce que révèle le défi du Covid19

Patrice Salini

24 novembre 2020

La crise pandémique en France, comme d'ailleurs dans de nombreux pays, a révélé de graves dysfonctionnements du « système politique ». En effet on peut considérer que les « réponses » politiques apportées, ont révélé tout à la fois une réelle impréparation, une difficulté à bien positionner le rôle de chacun, et celui de l'Etat et de ses structures, et ce qui est plus grave, une faible capacité d'apprentissage et de construction rationnelle de stratégies publiques.

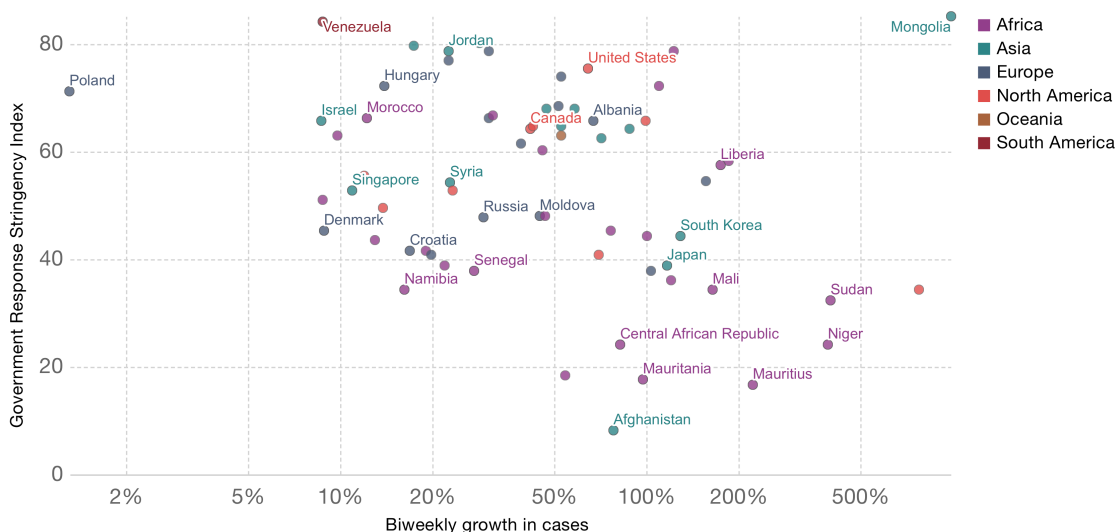
- L'impréparation est patente, et, somme toute, partiellement compréhensible, même si, dans le passé, plusieurs rapports ont pu alerter sur ce risque (audition de Didier Raoult au Sénat, 2010 : <https://youtu.be/tunOxz6Ce0M>). La question des masques, de la gestion de leur stock, puis celle de leur approvisionnement en ont été les révélateurs. Or, face à cet écueil, la stratégie gouvernementale s'est réfugiée curieusement dans une « réalité alternative », et une communication du déni, de nature à décrédibiliser l'action publique.
- La répartition des tâches a très vite été problématique, reflétant là aussi l'impréparation. En effet, le gouvernement a opté très vite pour le « tout-hôpital » (alors qu'on savait les hôpitaux sous tension), la décision centralisée, et la prédominance des ARS, là où les médecins de ville demandaient à être plus largement associés.
- Face à l'ampleur du phénomène épidémique, l'Etat a peiné à mettre en place une politique de test, et quand celle-ci a été possible, elle n'a été articulée avec une politique de soins, et des objectifs de connaissance statistique rationnelle (représentativité).
- L'importance dans de telles circonstances, de la recherche médicale a été fortement altérée par plusieurs mécanismes préjudiciables.

- On a assisté à une ingérence de l'Etat et de ses agences dans les stratégies de soin sans base scientifique incontestable et en l'absence de transparence et de débat contradictoire.
 - La prolifération des études publiées au niveau mondial a été fortement instrumentalisée et a permis d'animer des polémiques à la tonalité excessive, et des débats méthodologiques inadéquats en période d'urgence sanitaire.
 - Certaines études ont été tronquées du fait de l'arrêt de certains bras à la suite de l'étude (ensuite rétractée) du Lancet.
 - Certains sujets majeurs sont parfois moqués ou négligés (mutation du virus, immunité des anciens malades, etc...)
- Progressivement, sous l'égide du Président de la République mettant en oeuvre une politique hyper-centralisée et peu ouverte à l'évaluation pluraliste, la politique menée s'est avérée centrée presque exclusivement (en dehors des espoirs mis en avant de l'apparition d'un vaccin efficace), sur notre capacité à ralentir le flux d'hospitalisation par les seules mesures « physiques » (confinement, distanciation...). Politique qu'il faut bien entendu accompagner des mesures économiques et sociales évitant une dépression massive de l'économie et des dommages sociaux importants. Les annonces du 24 novembre viennent confirmer cette orientation majeure de prétendu « contrôle des flux ». Un sujet sur lequel des études produisent des résultats contradictoire, comme sur bien d'autres sujets. A tout le moins cela mérite réflexion

Government Response Stringency Index vs. Biweekly change in confirmed COVID-19 cases, Nov 24, 2020



– The Government Response Stringency Index is a composite measure based on nine response indicators including school closures, workplace closures, and travel bans, rescaled to a value from 0 to 100 (100 = strictest response).
 – The biweekly growth rate on any given date measures the percentage change in the number of new confirmed cases over the last 14 days relative to the number in the previous 14 days.



Source: Hale, Webster, Petherick, Phillips, and Kira (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker – Last updated 24 November, 20:10 (London time), European CDC – Situation Update Worldwide – Last updated 24 November, 10:06 (London time), Our World In Data CC BY

Du coup, on peut être raisonnablement tenté de s'interroger sur notre capacité, en France, et après une dizaine de mois d'expérience, d'avoir une approche véritablement rationnelle.

Examinons succinctement la question de la connaissance, et de l'éclairage des choix, tant il est vrai qu'il est nécessaire pour décider « rationnellement » de mobiliser les connaissances et de disposer d'un bon éclairage des choix.

La connaissance

La connaissance d'abord. Elle est factuelle d'une part - et repose donc sur des données qualitatives et quantitatives, qu'il faut donc « produire » - et elle découle par ailleurs de la recherche.

Connaissance factuelle

Rien n'indique qu'on mette actuellement une réelle rigueur pour suivre convenablement la pandémie.

- La connaissance des cas est fortement biaisée. Entre les tests « à la demande », c'est à dire « l'open-bar », les dépistages ciblés, et les campagnes menées, non seulement on ne teste pas selon un plan, mais personne ne sait si on construit quelque part un échantillonnage sérieux représentatif de la population... Autrement dit personne ne peut dire à quoi correspondent les « cas ». Ce qui remet en cause la valeur donnée au « nombre de cas » (variant en fonction du nombre de tests et de leur taux de positivité, dont on ne connaît pas la représentativité), et à ce qu'on appelle le taux d'incidence.

- Les tests PCR, selon la procédure utilisée en France, sont grossièrement à la fois des cas dont la charge virale est réelle, et d'autres qui sont très putatifs. Il est d'ailleurs désormais d'indiquer dans les résultats si la charge virale est faiblement positive. Mais les statistiques correspondantes ne sont pas publiées.

- On ne connaîtrait pas statistiquement ce qu'il advient des cas positifs, ni des éventuels soins prodigués, même s'ils sont suivis par la CNAM. Pas plus « en ville » qu'à l'hôpital.

On n'a rien mis en place pour suivre de manière globale l'impact des stratégies de soin. La controverse entre l'IHU et l'APHP sur les décès à l'hôpital n'a été nullement départagée, et n'a suscité aucune confrontation apaisée, j'oserais dire « scientifique »

La déficience de l'approche statistique livre donc une image tronquée, incomplète, déformée, et pleine de vides. Difficile, donc, de prendre des décisions éclairées, à moins qu'elles le soient de manière non transparente, ce qui est peu probable.

La recherche

La pandémie a ouvert une période exceptionnelle concernant à la fois la recherche elle-même et sa diffusion. (medrxiv.org : <https://connect.medrxiv.org/relate/content/181> recense par exemple plus de 10 800 « pré-print » au 24 novembre 2020)

Cela reflète à la fois un effort considérable de recherche mais aussi une double volonté de dissémination et de valorisation. Or, on a assisté, ce qui est normal, à de nombreuses controverses et à la publication d'articles manifestement d'intérêt variable, mais ce qui est plus grave, à des études dont on peut douter de l'honnêteté scientifique (affaire dite du Lancet), mais dont l'effet a été majeur. Enfin, on peut être surpris par le caractère très mécaniste des études. Ce qu'on peut ici regretter c'est le manque de travail scientifique sur les recherches, les méthodologistes l'emportant souvent sur l'analyse des apports des recherches. Certaines meta-analyses allant même jusqu'à « mettre dans le même panier » des données très disparates, et tirer des conclusions dépourvues de « bon » sens.

D'autre part, on ne tire en France aucune leçon des données relatives aux décès, et au taux de létalité en hôpital, en regard des stratégies de soin (<https://hcqtrial.com>). Pas plus qu'on ne tire de leçons des méta analyses portant sur les protocoles de soin (<https://c19study.com>).

Or, dans le domaine de la recherche on est passé du stade de la controverse ou de l'invective à celle d'une stigmatisation extrême et à la diffamation, et donc à la judiciarisation. Comment par exemple, Karine Lacombe, infectiologue, peut-elle dire dans Le Monde (22/11/2020) à propos de l'équipe de l'IHU (du professeur Raoult) : « *Mais voyez : la raison a fini par l'emporter sur la pensée magique et les études montrent aujourd'hui que cette équipe s'est trompée de A à Z.* », et surtout quelles preuves scientifiques peut-elle apporter et pourquoi une telle condamnation globale (« de A à Z ! ») ? Au fond ce qui choque c'est bien plus l'incapacité du débat scientifique que le fait, normal, qu'il y ait des désaccords. D'autant que désormais, les données disponibles et les études publiées apportent à minima le sentiment qu'il y a, à tout le moins, matière à débat. Or, on le sait il y a derrière les polémiques des questions légitimes (éthiques, méthodologiques, morales, ...), nous en avons déjà parlé, mais aussi d'autres qui malheureusement suggèrent l'influence de facteurs économiques ou de conflits d'intérêts.

L'éclairage des choix

Nous sommes donc dans une situation où l'éclairage des choix n'est pas ou plus rationnel. La vision statistique tout comme l'apport de la recherche ne permettent guère actuellement d'éclairer de manière sereine les choix politiques.

Par exemple l'attitude de l'Etat vis à vis de l'hydroxychloroquine (HCQ) n'est plus aujourd'hui rationnelle, puisque fondée sur un article manifestement douteux et depuis retiré (le 4 avril 2020 !).

L'affirmation réitérée de l'absence de traitement, est régulièrement contredite, sans qu'on en tire de conclusion. Or les études peuvent montrer des variations de risque de décès considérables (« *Pattern of SARS-CoV-2 infection among dependant elderly residents living in retirement* » , Gautret et Alii, à propos des Maisons de retraite à Marseille). Et pour en rester à l'hydroxychloroquine, de très nombreuses études (177 au 22/11/2020) confirment l'intérêt de cette molécule (<https://c19study.com>). Mais on peut parfaitement arguer que les choix, nécessairement faits en avenir incertain, et sur la base de connaissances imparfaites, peuvent s'avérer être une erreur, comme ce fût le cas avec le Remdesivir en Europe, commandé massivement pas la Commission, et désormais déconseillé par l'OMS. Alors on peut s'étonner à la fois de la volonté des pouvoirs publics d'interférer avec les choix thérapeutiques des médecins, et, ce qui est tout aussi discutable, de ne pas chercher à les aider en favorisant l'analyse et la transparence autour des débats scientifiques. Au lieu de quoi, les instances qui devraient « pacifier » le débat, contribuent actuellement à le rendre plus que tendu.

C'est donc, clairement un échec du processus d'éclairage des choix, puisqu'à la place d'une approche sereine, raisonnable, transparente et contradictoire, s'est installé un climat fanatique où l'on cherche manifestement plus à excommunier qu'à comprendre sa pratique.

L'enjeu est aujourd'hui de savoir s'il est encore possible de construire une approche rationnelle, fondée sur une approche statistique cohérente, j'oserai dire scientifique, ce qui n'élimine nullement les débats, les incertitudes, les controverses, mais nous sortirait du brouillard actuel. J'ai le sentiment que c'est bien entendu possible, à condition que chacun remplisse sa tâche. Nous avons besoin de statistiques, de dispositifs d'observation, d'une objectivation des données, d'un débat serein sur les résultats observationnels, et d'un éclairage des choix transparent.

Mélanges

Au total, on peut donc considérer que la gestion de la crise du Covid, du moins dans sa dimension sanitaire et ses conséquences relatives aux libertés publiques, aurait pu et du respecter un certain nombre d'orientations prioritaires et de principes, ce qu'elle n'a pas fait.

1. L'urgence était d'abord de protéger, de soigner, et de comprendre. Ce qu'on n'était pas préparés à faire, au point de confondre le pragmatisme nécessaire et certaines modes méthodologiques, de tenir des discours contradictoires (masques, tests, ...) et de ne pas se mettre en situation de disposer a minima de données permettant de suivre statistiquement l'évolution de l'épidémie.

-
2. A ce niveau des principes évidents n'ont pas été respectés. La protection appartient à la puissance publique, mais ne peut pas être conçue de manière uniforme et centralisée. Le soin appartient aux médecins et doit s'appuyer sur les connaissances scientifiques. En l'espèce on a voulu privilégier une certaine forme de recherche par rapport aux soins. La connaissance statistique de l'épidémie doit découler de vrais programmes statistiques, et non du seul traitement des données administratives. La recherche de nouveaux médicaments ne doit pas handicaper la mise en oeuvre des soins et l'usage de molécules connues. Enfin, l'appréciation des soins doit faire l'objet d'un partage scientifique contradictoire et transparent, et non de polémiques hystérisées sous l'égide de la course à la publication.
 3. La dimension de l'enjeu de santé publique ne justifie aucunement le recul du rôle des élus à tous niveaux, ni l'éclairage des choix publics dans un contexte assurant le maximum de transparence. Il ne justifie pas plus une hyper centralisation des décisions ni la place donnée au Conseil de défense et au Président de la République.

Bref, la crise est révélatrice de bien des travers de nos institutions et de nos méthodes d'action publique, il serait bien d'en prendre conscience.

P.S.